

Disturbi dello Spettro Autistico —

Parte 1 · Schema

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 08

Definizione

- **ASD** → sindrome comportamentale da disordine dello sviluppo biologicamente determinato
 - Diagnosi → **comportamentale** (osservazione), non biologica
 - Cause → neurobiologiche + costituzionali + psicoambientali
 - Esordio → prima dei **3 anni** (diagnosi possibile anche in età adulta)
 - Disabilità **permanente** (caratteristiche modificabili nel tempo)
 - Frase-chiave → "**L'autismo non si cura, si educa**"
-

Dati chiave

- **USA → 1 su 36** | **Italia → 1 su 77** | **Svizzera → ~80.000 persone**
 - **4× più frequente nei maschi**
 - Aumento apparente dei casi → miglioramento diagnosi + ampliamento definizione + più sensibilizzazione
 - **Intervento precoce** → **fattore più determinante sull'evoluzione**
-

Storia — Autori principali

Anno	Autore	Contributo
1911	Eugen Bleuler	Conia "autismo" (gr. αὐτός = se stesso)
1943	Leo Kanner	

Anno	Autore	Contributo
		"Autismo precoce infantile" — 11 bambini, ipotesi innata
1944	Hans Asperger	Profilo con buone capacità cognitive + deficit pragmatica
1955	Kanner (errore)	Disturbo psicogeno: genitori "troppo impegnati"
1960s	Bruno Bettelheim	"Madre frigorifero" — bambini tolti alle famiglie
1964	Bernard Rimland	Disturbo neurologico
1970	Ivar Lovaas	Causa biologica + intervento precoce (ABA)
1971	Eric Schopler	Genitori competenti, origine organica, terapia educativa
1978	Michael Rutter	Non è psicosi; esordio < 3 anni
1979	Wing & Gould	60% con gravi deficit intellettivi; smentiscono mito del genio
1983	Lorna Wing	Definisce la triade + introduce concetto di spettro
2013	DSM-5	Unica etichetta ASD + 3 livelli di gravità + diade diagnostica

Falsi miti

- "Capacità eccezionali sempre" → **falso** (60% ha gravi deficit intellettivi)
- "Se vuole capisce / parla" → **falso** (deficit neurologico, non volontà)
- "È una psicosi" → **falso** (disturbo del neurosviluppo)
- "Si chiude per scelta" → **falso**
- "Non vuole stare con gli altri" → **falso** (non sa come farlo)
- "I genitori sono la causa" → **falso**

DSM-5: Diade Diagnostica

A. Comunicazione e interazione sociale (3 criteri)

- **A.1** → deficit reciprocità socio-emotiva
 - non risponde al nome, evita contatto visivo
 - non legge emozioni, gesti, tono di voce altrui
 - comportamenti aggressivi da stress/sovraccarico
- **A.2** → deficit comportamenti comunicativi non verbali
 - gesti, espressioni, posture: difficoltà a usarli e interpretarli
 - comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrate
 - lettura letterale del linguaggio (no metafore, no sottintesi)
- **A.3** → deficit sviluppo e gestione relazioni
 - difficoltà ad adattarsi ai contesti sociali
 - mancanza di gioco simbolico spontaneo
 - difficoltà nel fare e mantenere amicizie

B. Pattern ristretti e ripetitivi (4 criteri)

- **B.1** → stereotipie motorie, ecolalia, linguaggio idiosincratico
- **B.2** → insistenza nella sameness (routine rigide, stress da cambiamenti)
- **B.3** → interessi ristretti e fissi, anomali per intensità/profondità
- **B.4** → iper- o ipo-reattività sensoriale
 - SIRS → ricerca ripetitiva di stimoli sensoriali
 - HYPO → risposta ridotta (es. alta tolleranza al dolore)
 - HYPER → risposta eccessiva (es. avversione a suoni/tessuti)
 - EP → percezione aumentata / enhanced perception

Condizioni per la diagnosi

- Presenti nel **periodo precoce dello sviluppo**
 - Causano **compromissione significativa** del funzionamento quotidiano
 - **QI** → **non è un criterio diagnostico**
-

3 Livelli di Gravità

Livello	Compromissione	Supporto richiesto
1	Ridotta	Supporto (ex Asperger / alto funzionamento)
2	Intermedia	Supporto sostanziale
3	Grave	Supporto molto sostanziale

Specificatori: con/senza compromissione intellettiva · con/senza compromissione del linguaggio · con condizioni mediche/genetiche associate · con altri disturbi del neurosviluppo

Sensorialità — Dati Greenspan & Wieder (1997, n=200)

- 19% → iposensibilità
 - 39% → ipersensibilità
 - 39% → entrambe
-

Comorbidità frequenti

Bambini	Adulti
ADHD 35%	Depressione 20-40% (70% lifetime)
Problemi attenzione 60-70%	DOC 44-60%
Disturbi d'ansia 40-50%	Disturbi di personalità 70-90%
Dislessia 15-20%	Disturbi alimentari 20-30%

Neurodiversità e Spettro

- **Neurodiversità** (Judith Singer, anni '90) → variazione neurologica = naturale variabilità umana
 - **Spettro** → tre significati:
 - gravità variabile (dimensionalità)
 - **continuità con popolazione generale** (tratti distribuiti in tutti)
 - diversi sottogruppi qualitativi
 - **Regola: "Hai visto una persona con ASD — ne hai vista solo una"**
-

Parole chiave

ASD · diade diagnostica · ecolalia · pragmatica del linguaggio · neurodiversità · sameness · stereotipie · ipersensibilità · iposensibilità · SIRS · HYPO · HYPER · EP · intervento precoce · neurotipico · comorbidità · spettro